

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5111977-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: RENATO LEOCADIO DA SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. COLONOSCOPIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA E INÍCIO DE TRATAMENTO. *PERICULUM IN MORA* CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5111977-97.2024.4.02.5101

510015372444 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5111977-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: RENATO LEOCADIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela União em face da decisão do Juízo de origem que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:

"RENATO LEOCADIO DA SILVA, portador de neoplasia maligna de reto, propõe a presente demanda, pelo rito dos Juizados Especiais Federais, por meio da qual objetiva, com pedido de antecipação de tutela, requer a condenação da União Federal, do Estado/RJ e do Município do Rio de Janeiro, em responsabilidade solidária, na obrigação de realizarem internação para hospital com suporte em oncologia, de acordo com as suas necessidades clínicas.

Parecer técnico acostado pelo NAT-Jus no evento 7.1.

Passo a decidir.

Inicialmente, de acordo com a documentação médica que instrui a exordial, verifico que o autor está debilitado, com quadro clínico de obstrução intestinal por tumor de reto, com necessidade de internação para realização de colonoscopia com biópsia.

Nesse contexto, informa-se que o procedimento vindicado está indicado para o manejo do quadro clínico do paciente e, além disso, que é coberto pelo SUS, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP).

*Pois bem, com o intuito de verificar o correto encaminhamento do autor junto aos sistemas de regulação, em consulta à plataforma da Secretaria Municipal de Saúde - Transparência do SISREG Ambulatorial, foi localizada solicitação de colonoscopia, com diagnóstico de neoplasia maligna do reto, classificação de risco "**Vermelho - Emergência**", solicitada em **06/09/2024**, pelo Centro Municipal de Saúde Flavio do Couto Vieira, com situação: "Negado", sob a seguinte justificativa: "Risco cirúrgico ASA III, deve ser via internação eletiva, visto que caso ocorra alguma intercorrência durante o procedimento, a unidade irá dispor de leito de UTI".*

Com efeito, o NAT-Jus sugere que "a unidade solicitante adeque a solicitação realizada no SISREG, para que o cadastro do Autor seja regularizado e possa retornar a fila de espera para o atendimento necessário ao seu caso".

Passo ao exame do pedido de tutela de urgência.

Ora, a Lei nº 12.732, de 22.11.2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada no âmbito do SUS, assim estabelece:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade

terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso."

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

"Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)."

"Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia.

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do "caput" terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde."

"Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente.

§ 1º O prazo previsto no "caput" poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no "caput" aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

II - câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e

III - casos sem indicação de tratamento descritos no art. 2º."

Firmadas essas premissas, constata-se a ultrapassagem do prazo máximo normativo - de 60 dias, repise-se - para o fornecimento da consulta e dos demais tratamentos oncológicos necessários à recuperação da saúde do paciente.

Ademais, deve-se destacar que a solicitação em tela é datada de 06/09/2024, sendo evidente que tamanha espera não se coaduna com a urgência do quadro do autor, com classificação de risco **"Vermelho - Emergência"**.

Evidenciam-se, dessarte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), em razão dos riscos à saúde da parte autora que a demora do processamento pode provocar, além da probabilidade quanto ao direito, atribuída ao princípio de prova acerca da situação médica da parte autora, sobretudo porque, de acordo a Lei 12.732/12, os pacientes acometidos de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado, quando decorrido o prazo de 60 dias, previsto nas normas acima mencionadas, o que se verifica no caso concreto.

Nesse prisma, deve-se reiterar que os referidos pressupostos da tutela de urgência estão suficientemente demonstrados nos autos, em sede de cognição sumária, mormente por meio da documentação médica anexada à petição inicial e o parecer técnico emitido pelo NAT, o que se harmoniza aos enunciados de números 51 e 92 das Jornadas de Saúde do CNJ, adiante transcritos:

"ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

ENUNCIADO Nº 92 Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente."

Consigne-se que o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei nº 14.238/2021) preconiza, em seu art. 4º, a prioridade como direito fundamental, nos seguintes termos:

"Art. 4º São direitos fundamentais da pessoa com câncer: (...)

V - prioridade; (...)

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa com câncer aquela que tenha o regular diagnóstico, nos termos de relatório elaborado por médico devidamente inscrito no conselho profissional, acompanhado pelos laudos e exames diagnósticos complementares necessários para a correta caracterização da doença.

§ 2º Entende-se por direito à prioridade, previsto no inciso V do caput deste artigo, as seguintes garantias concedidas à pessoa com câncer clinicamente ativo, respeitadas e conciliadas as normas que garantem o mesmo direito aos idosos, às gestantes e às pessoas com deficiência:

I - assistência preferencial, respeitada a precedência dos casos mais graves e outras prioridades legais;

II - atendimento nos serviços públicos nos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, respeitada a precedência dos casos mais graves e de outras prioridades legais; (...)"

Impende consignar que a qualidade de idosa ostentada pela parte autora - pessoa com 85 anos de idade, repise-se - impõe ao Poder Público deveres específicos de proteção à sua saúde, com absoluta prioridade, como se depreende das seguintes regras insculpidas na Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

"Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º A garantia de prioridade compreende: (Redação dada pela Lei nº 13.466, de 2017)

I - atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

II - preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;

III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso;

VIII - garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

Art. 15: É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de:

I - cadastramento da população idosa em base territorial;

II - atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;

III - unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;

IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;

V - reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde.

§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação".

Convém notar, por derradeiro, como salientado pelo órgão técnico, que o Estado do Rio de Janeiro conta com uma Rede de Alta Complexidade Oncológica, razão por que o ente estadual deve, nesse primeiro momento, ser o responsável por alocar ou direcionar a parte autora para a unidade do SUS adequada a providenciar a respectiva internação e tratamento subsequente, observadas as regras de competência administrativa e organizacional de cada ente no âmbito da rede pública de saúde.

Ante o exposto, nos moldes do art. 300 do CPC, **DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA** vindicada, determinando que os réus, solidariamente, de acordo com as suas atribuições previstas nos atos normativos vigentes, adotem os procedimentos necessários para regularizar a situação do autor junto aos sistemas de regulação e, em seguida, promovam a internação/transferência do paciente para unidade com suporte oncológico a fim de realizar o procedimento pleiteado, bem como posterior tratamento adequado ao seu quadro.

Intime-se, inicialmente, o Estado do Rio de Janeiro para cumprimento da obrigação em tela, no prazo de até 5 (cinco) dias."

Em seu recurso, a União sustenta a carência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a inclusão da parte autora no sistema de regulação é pressuposto para o atendimento a fim de se observar a fila de acordo com as prioridades e as urgências de cada paciente. Alega ainda a necessidade de observância da fila, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Subsidiariamente requer o redirecionamento para o Estado ou Município, nos termos do tema 793.

Efeito suspensivo indeferido no Evento 3.

É o breve relatório.

VOTO

Conforme mencionado pelo NAT o Autor esteve regulado no SISREG para colonoscopia em 06/09/2024. No entanto, o procedimento foi negado, pois em razão do risco cirúrgico do Autor tal procedimento deveria ser feito via internação (evento 7, PARECER1).

DADOS DA SOLICITAÇÃO			
Código da Solicitação:		Situação Atual:	
557169507		SOLICITAÇÃO / NEGADA / REGULADOR	
CPF do Médico Solicitante:	CRM:	Nome Médico Solicitante:	Vaga Solicitada:
---	3306107	NILCE GLAUCIELE SANTOS LIMA	1ª Vez
Diagnóstico Inicial:	CID:	Risco:	
NEOPLASIA MALIGNA DO RETO	C20	VERMELHO - Emergência	
Central Reguladora:			
RIO DE JANEIRO			
Unidade Desejada:	Data Desejada:	Data Solicitação:	
---	---	06/09/2024	
Procedimentos Solicitados:	Cód. Unificado:	Cód. Interno:	
COLONOSCOPIA	0209010029	1711101	
HISTÓRICO DE OBSERVAÇÕES			
Solicitante:	Data:	Hora:	Situação:
NILCE.SANTOSSOL	06/09/2024	07:58	PENDENTE
Observação:			
Paciente 84 anos, hipertenso, foi internado no dia 09/06/2024 até 12/06/2024 no hospital Municipal Albert Schweitzer, para a realização de um procedimento transversostomia em alça derivação do transito intestinal com obstrução por tumor de reto, foi medicado com metronidazol + ciprofluvacino. Ao exame físico PC em bom estado geral, afebril, anictérico, acianótico, hidratado, torax sem patologia, Abdome distendido, depressível, não dor a palpação superficial, ruídos hidro ar presente, sem sinais de irritação peritonal com colostomia funcional, permeável, com fezes. retorna ao atendimento no hospital Municipal Albert Schweitzer que encaminhou a paciente com uma Solicito colonoscopia descompressão, sem abordagem da lesão primária. solicito junto uma biopsia para melhor seguimento e conduta. Desde já grato. IMC: 25.36, ASA III.			
Regulador:	Data:	Hora:	Situação:
JOAO.XAVIERREG	17/09/2024	15:38	NEGADO
Justificativa:			
Risco cirúrgico ASA III deve ser via internação eletiva, visto que caso ocorra alguma intercorrência durante o procedimento, a unidade irá dispor de leito de UTI. Att.			

Nos documentos médicos juntados com a inicial verifica-se que o Autor depois de sofrer uma intervenção cirúrgica (trasversostomia em alça) teria sido encaminhado para realizar colonoscopia + biópsia. No entanto, tal procedimento não pode ser realizado em ambiente ambulatorial diante das circunstâncias pessoais do paciente, estando o mesmo até o momento aguardando a realização do procedimento para poder dar início ao seu tratamento (evento 1, ANEXO2, evento 1, ANEXO6 pag. 4/6)

Paciente Renato Leocardio da silva, hipertenso, foi internado no dia 09/06/2024 até 12/06/2024 no hospital Municipal Albert Schweitzer, para atendimento pela emergência com um quadro de obstrução intestinal onde foi realizado um procedimento transversostomia em alça derivação do transito intestinal com obstrução por tumor de reto. Veio posteriormente para atendimento nesta unidade em demanda livre onde foi atendido e solicitado uma colonoscopia + biopsia para confirmação do diagnostico para melhor seguimento do paciente. Paciente também foi encaminhando para uma avaliação de ostomizado pelo SISREG. Foi solicitado para uma avaliação antes do procedimento via Sisreg. Foi avaliado no serviço para onde foi encaminhado para colonoscopia, onde foi constatando que, devido ao quadro clinico do paciente, não poderia ser realizada a colonoscopia + biopsia em ambiente ambulatorial pois o paciente se encontrava muito debilitado naquele momento então foi sugerido que o procedimento fosse realizado por internação eletiva, que foi solicitada no dia 26/09/2024 via SUBPAV para realização da colonoscopia + biopsia. A internação eletiva se faz necessária devido as condições clinicas que o impossibilitam de realizar o exame em ambiente ambulatorial, quais sejam: paciente idoso, de idade avançada, com 85 anos com quadro de anemia com hemoglobina 9,0g/dl, perda de peso acentuado, e ostomizado. Dessa maneira, solicito internação eletiva com maior brevidade possível (devido) gravidade do caso para o referido paciente para realização de colonoscopia + biopsia em ambiente hospitalar.

Declaro para os devidos fins que o paciente:

Renato Heradio da Silva

apresenta condições clínicas que impossibilitam de realizar o exame de colonoscopia em ambiente ambulatorial. Dessa maneira, encaminho o paciente para realizá-lo em ambiente hospitalar pelas seguintes circunstâncias: Usuário idoso, idade avançada, 84 anos. Realizou o procedimento de transcolectomia recente, dia 09/06/2024, Anemia, Hb: 9,0 g/dl. necessita realizar o preparo e o procedimento internado p/ melhor suporte.
* Procedimento com menos de três meses.

Att.

Dr. Walter Razzano
Médico Anestesiologista
CRM 17.10224

A Lei nº 12.732, de 22.11.2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada no âmbito do SUS, assim estabelece:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único."

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso."

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

"Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)."

"Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia.

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do "caput" terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde."

"Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente."

§ 1º O prazo previsto no "caput" poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no "caput" aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

II - câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e

III - casos sem indicação de tratamento descritos no art. 2º."

Verifico que a parte autora até o momento não logrou realizar o procedimento, que se mostra necessário para iniciar o tratamento que se encontra dependente do resultado da biópsia, conforme se depreende do documento de fls. 7 do evento 1, ANEXO6 datado de julho de 2024.

Dados do Encaminhamento

Especialidade encaminhada	Nome do Profissional (sugerido)	Unidade (sugerida)
CONSULTA EM ANCOLOGIA	avaliado por paciência O. Tomazello	

Dados de Atendimento

	Peso (kg)	Altura (m)	Pressão (mm Hg)	Temperatura
Motivo do Encaminhamento (dados clínicos) Paciente com 84 anos, com diagnóstico de Neoplasia Maligna do Reto, foi submetido a uma cirurgia Transvessostomia em alça por obstrução intestinal por tumor de reto, no dia 09/06/2024,				
Exames Solicitados e resultados Solicito avaliação pois o paciente relata não ter condições financeiras para a compra da bolsa para troca da mesma conforme orientação médica cirúrgica. Desde já grato. Paciente se encontra à espera do atendimento especializado em ancologia até o momento por causa do resultado da biopsia.				
CID 10 Z933	Data do Encaminhamento 26.07.2024			

Dr(a) NILCE GLAUCIELE SANTOS LIMA
Médico Clínico - Modelo B
CRM 3306107

A demora na confirmação do diagnóstico e consequentemente início do tratamento adequado pode comprometer o quadro clínico do Autor, configurando, portanto, o *periculum in mora*.

No tocante à alegação de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que a urgência e a necessidade do procedimento encontram-se devidamente demonstradas nos autos, não cabendo afastá-las em razão de alegações genéricas e não comprovadas por parte da União.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada por conta da ausência de tal requisito teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

Entendo, ainda, que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade para afastar a irreversibilidade do provimento adotado, a fim de que seja protegido o interesse maior lastreado no direito constitucional à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CRFB/88, em detrimento do interesse financeiro do Estado.

No que diz respeito ao direcionamento do cumprimento da tutela de urgência, a 8.ª Turma Recursal já assim firmou seu entendimento:

"SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO, COM BASE NA TESE 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em recurso onde ente federado alega ilegitimidade passiva, com fulcro na Tese 793 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a atribuição de fornecer medicamento/tratamento é de outro ente federado, vale dizer, a interpretação mais consentânea com a jurisprudência do STF é a de que os cidadãos podem postular a concessão de tais medicamentos de todos os órgãos federados, sendo todos legítimos para a causa, porque fazem parte da relação jurídico-material primária, por força da Constituição Federal, sendo ainda, solidariamente responsáveis, com base no mesmo diploma. O que diz o tema 793 do Supremo Tribunal Federal é que o juiz do cumprimento da sentença irá direcionar o ofício para o devedor principal, em primeiro lugar. Assim, a discussão é se o ente federado é o devedor principal ou não, ou seja, aquele que será oficiado em primeiro lugar para cumprir a obrigação. 8 TR - Sessão de 11/06/2019 - Relator: LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA - Processo: 0190958222017402515102."

Observa-se que nos autos de origem já houve o direcionamento do cumprimento para o Estado do Rio de Janeiro.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.